

Protocole opératoire

Patient : SCHNEIDER Lukas, 28.08.1990

Intervention du 24.03.2026, Hôpital d'Yverdon, service de chirurgie de la main.

Sous anesthésie locorégionale, garrot pneumatique à 250 mmHg.

Exploration de la plaie palmaire : section complète du fléchisseur commun profond II, section partielle (70 %) du fléchisseur commun superficiel III. Pédicules vasculo-nerveux collatéraux intacts, testés au microscope.

Ténorrhaphie selon Kessler modifié à quatre brins, surjet épitendineux. Fermeture cutanée par points séparés. Attelle dorsale poignet à 30° de flexion, MCP à 60°, IP en extension.

Durée : 95 minutes. Suites immédiates simples.